SDD 274 Sujet n°1

Spécialité : Médecine infectieuse

Date : 04/10/2023
Auteur : Angèle ROUDEAU (DES de maladies infectieuses et tropicales - ECN 2021)
Relecteur(s) : Robin ELAYLI (DES de psychiatrie - ECN 2023), Sébastien VILLARD (DES de médecine interne - ECN 2023), Lucie-Lou VIAL (DES MAR, EDN 2023/2024)

Domaine d'apprentissage principal	Stratégie pertinente de prise en charge
Domaine d'apprentissage secondaire	Annonce/Information au patient
Item(s) en lien avec la station	159 Tuberculose
Situation(s) de départ en lien avec la station	SDD 274 Prise en charge d'un patient présentant une tuberculose bacillifère SDD 310 Prévention chez un malade contagieux SDD 347 Situation sociale précaire et isolement SDD 188 découverte de bacilles acido-alcoolo-résistants (BAAR) sur un crachat SDD 352 expliquer un traitement au patient (adulte/enfant/adolescent)
Matériel nécessaire à la station	Papier et stylo
Contexte de la station	Hospitalisation en salle d'infectiologie

ECOS TACFA
INSTRUCTIONS POUR LE/LA CANDIDAT.E

Contexte :
Vous êtes un.e interne en stage d'infectiologie. Vous avez dans votre service Mme Tur, âgé de 64 ans qui présente depuis plusieurs mois une perte de poids (10 kg en 2 mois), des sueurs nocturnes, une asthénie importante et finalement une toux, pour laquelle elle s'est présentée aux urgences qui l'ont transférée en infectiologie.

Le BK crachat initial revient positif > 100 BAAR/champ.

PCR *M.tuberculosis* positive.
PCR rpoB négative.

Prise de sang à l'arrivée :
- NFS 12 G/L leucocytes dont 9 G/L PNN
- Na 129 mmol/L, K 4 mmol/L
- Créatininémie 70 µmol/L
- ASAT / ALAT < Norme
- gGT < Norme
- PAL < Norme

La patiente est d'origine malienne, arrivée en France à 25 ans.
Elle est célibataire et vit avec son fils de 20 ans. Elle travaille en tant que vendeuse.

Consignes :
Vous avez 8 minutes pour :
- Annoncer et expliquer la pathologie en terme simple
- Expliquer la prise en charge médicamenteuse et non médicamenteuse

Vous ne devez pas :
- Organiser le dépistage des proches
- Rédiger une ordonnance
- Enoncer d'examens complémentaires

Attention : Vous avez 8 minutes. Au signal sonore, passez à la station suivante.

Il s'agit d'une station sans patient standardisé.

ECOS TACFA
GRILLE D'EVALUATION

Consigne(s) à l'évaluateur :

1. Annonce de la tuberculose		
1.	Annonce le diagnostic tuberculose pulmonaire	1 pt
2.	Explication : infection des poumons, bactérie dans les poumons.	1 pt
3.	Explication : Pathologie qui se traite et se guérit	1 pt
5.	Énonce la nécessité de mettre des masques FFP2 à l'entrée pour les soignants	1 pt
2. Explication de la prise en charge		
1.	Isolement respiratoire avec masque chirurgical pour la patiente	1 pt
2.	Début médicaments rapide *(ok maintenant si met à jeun ou demain matin, pas d'intérêt à repousser le début de traitement)*	1 pt
3.	Explication médicaments : - 4 différents pendant 2 mois : rifampicine, isoniazide, ethambutol, pyrazinamide - ET Puis 2 différents pendant 4 mois : rifampicine + isoniazide	1 pt
4.	Énonce une durée totale de traitement de 6 mois	1 pt
5.	Nécessité d'une bonne observance pour efficacité	1 pt
6.	Prescrit les médicaments à jeun 2h avant de manger	1 pt
7.	Indique que les liquides biologiques vont être oranges pendant 6 mois du fait des médicaments (urine, larmes)	1 pt
8.	Autres effets secondaires : troubles digestifs possibles, neuropathie périphérique, … (1 minimum)	1 pt
9.	Prévient du risque d'interaction médicamenteuse avec rifampicine : pas d'automédication.	1 pt
10.	Indique la nécessité de réaliser des prises de sang régulières pour suivi de la tolérance	1 pt
3. Communications et attitudes : 5 pt		

3. APTITUDE À FOURNIR LES RENSEIGNEMENTS AU PATIENT / AUX AIDANTS

Performance Insuffisante 0 point	**Performance Limite** 0,25 point	**Performance Satisfaisante** 0,5 point	**Performance Très Satisfaisante** 0,75 point	**Performance Remarquable** 1 point
Renseigne le patient / aidant de manière inadaptée (ex. informations inexactes) ou ne fait aucun effort pour renseigner le patient/aidant	Donne des renseignements de façon incomplète ou s'attarde à des renseignements éloignés du problème	Donne des renseignements de façon adaptée. Veille quelque peu à ce que le patient /aidant comprenne	Donne des renseignements de façon adaptée. Veille à ce que le patient / aidant comprenne	Renseigne avec justesse et illustre ses explications pour qu'elles soient bien comprises

1. APTITUDE À ÉCOUTER : le patient / le pair

Performance Insuffisante 0 point	**Performance Limite** 0,25 point	**Performance Satisfaisante** 0,5 point	**Performance Très Satisfaisante** 0,75 point	**Performance Remarquable** 1 point
Interrompt le patient /pair de façon inappropriée Ignore les réponses du patient/collègue	Se montre impatient	Est attentif aux réponses du patient/pair	Est attentif aux réponses du patient/pair Adopte la technique de reformulation si l'information est imprécise ou éloignée des objectifs.	Porte une attention soutenue aux réponses du patient/pair et à ses préoccupations.

11. APTITUDE À PLANIFIER LES SOINS (= approche centrée sur le patient)

Performance Insuffisante 0 point	**Performance Limite** 0,25 point	**Performance Satisfaisante** 0,5 point	**Performance Très Satisfaisante** 0,75 point	**Performance Remarquable** 1 point
Le projet des soins ne correspond pas au tableau clinique ou ne prend pas en compte le patient et ses besoins	Le projet des soins est adapté au tableau clinique Omet quelque fois de prendre en compte les capacités / contraintes du patient	Fait participer le patient à la planification de ses soins *(ex invite le patient à poser des questions)*	Favorise la prise de décision en partenariat avec le patient.	Favorise la prise de décision en partenariat avec le patient. Renforce la confiance du patient et son autonomie

4. APTITUDE À STRUCTURER/ MENER L'ENTREVUE

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Approche désordonnée	Entrevue peu structurée, présente les difficultés à recadrer les discussions qui s'éloignent des objectifs	Entrevue centrée sur le problème et couvre les éléments essentiels	Entrevue menée de façon logique, structurée, centrée sur le problème, ne cherche pas l'information non pertinente	Entrevue ayant un but précis, approche intégrée

5. COMMUNICATION NON VERBALE

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Se comporte de manière inappropriée (p. ex. ne regarde pas son interlocuteur, se comporte de manière offensante ou agressante) ou porte des jugements	Tente d'établir un contact visuel. Présente les difficultés à établir la conversation (p.ex. priorise l'accomplissement de la tâche clinique) et cela peut induire la frustration du patient/pair	Regarde le patient/ pair la majeure partie du temps Établit la conversation	Regarde le patient/ pair la majeure partie du temps Est attentif aux indices du patient/pair et réagit de manière appropriée par son comportement/gestes.	Montre une bonne maîtrise de ses comportements et cherche à les adapter afin de favoriser la conversation /établir une relation.

TOTAL (/ 20)	points

<u>Éléments de rétroaction :</u>

- Commencer par essayer de savoir où en est la patiente (type « on a réalisé beaucoup d'examens pour essayer de trouver la cause de votre fatigue, qu'est ce qu'on vous a expliqué jusqu'ici ?») pour initier l'annonce
- Vérifier que le patient comprend ce qu'on dit (faire répéter, demander si c'est clair …)
- Si chaise disponible, ne pas hésiter à s'asseoir pour ne pas être au-dessus du patient pendant toute l'annonce
- Chez des patients à bas niveau socio-économique, éviter le jargon médical (exercice difficile dans un ecos puisqu'on vous note aussi sur le contenu, mais il faut arriver à transmettre au patient les informations nécessaires à sa bonne prise en charge)
- Mettre le masque FFP2 dès que suspicion de tuberculose bacillifère. Ne pas l'enlever durant l'examen.

ECOS TACFA
SCÉNARIO PATIENT SIMULÉ

Consignes génériques pour le patient :

- Ce que tu peux dire spontanément ou sous condition est clairement indiqué
- Si le candidat pose une question dont la réponse ne se trouve pas dans le scénario, n'improvise pas et réponds « je ne sais pas » ou « c'est normal ».

Rappel du scénario du candidat :

Annonce et explication d'une tuberculose bacillifère.

Plan de la station ECOS :

Masques FFP2 et chirurgicaux à l'entrée Allongé dans un lit d'hôpital avec un masque chirurgical.

<u>Phrase de démarrage du patient simulé (par <3) :</u>

Docteur, est-ce que vous savez ce que j'ai ?

Identité du patient :

Mme Tur, 64 ans, 1m65, 42 kg, IMC 15

Mode de vie :

Vendeuse en magasin

Comportement global :

Faible compréhension des termes médicaux, faible niveau socio-culturel mais adhérente au traitement. Inquiète.

Antécédents personnels :

2 accouchements par voie basse sans complication

Antécédents familiaux :

Non connus

Médicaments :

Paracétamol si besoin

Symptômes positifs :

- Fatigue
- Toux
- fébrile

Constantes :

39°C, 135/67, 100 bpm, 98% AA.

Questions de relance :

- Demander comment on a attrapé la maladie après l'annonce
- A 5 min, si l'étudiant n'a pas évoqué la thérapeutique : "mais ça se traite ?"

ECOS TACFA
FEUILLET ORGANISATEUR (FACULTATIF)

Plan de la station ECOS :

Patient allongé dans un lit (hospitalisé)
Feuilles stylo disponibles si besoin de faire un dessin / schéma pour explication traitement.
Idéalement une chaise à côté.
Masque chirurgicaux et FFP2 proposés à l'entrée